

PAS, Napsin A が陰性であり, p40 や CK5/6 が陰性。

b 腫瘍マーカー

これまでの大細胞癌の中に WHO 分類第 4 版以降は腺癌や扁平上皮癌と診断される場合も多く, 現分類での大細胞癌に特異的な腫瘍マーカーはない。複数の腫瘍マーカーを測定し上昇した腫瘍マーカーをモニタリングしていくのが現状である。

c 確定診断

除外診断となるが免疫染色が必要であり, また腫瘍全体を観察するため外科的切除検体による組織診断が望ましい。

治療と予後

大細胞癌の治療は, 他の非小細胞肺癌と同様に, 臨床病期に従って手術・放射線治療・薬物療法を適切に組み合わせることによって治療方針が決定されている。進行・再発症例においてはドライバー遺伝子変異/転座の発現 PD-L1 免疫組織化学染色検査 (IHC) などの分子診断を行い, 薬物療法 (細胞傷害性抗癌薬, 分子標的治療薬, 免疫チェックポイント阻害薬) を検討する。

Advanced

神経内分泌特性を除く大細胞癌は分類が度々変化しており, 診断に施設間で差があることが知られている。正確な診断には手術検体が必要でありこれらの要素がこの分野の臨床研究を難しくしている。

7

腺扁平上皮癌

adenosquamous cell carcinoma

到達目標

- 肺腺扁平上皮癌の病因・病態が説明できる
- 肺腺扁平上皮癌の症候・身体所見が説明できる
- 肺腺扁平上皮癌の診断・検査について説明できる
- 肺腺扁平上皮癌の治療について説明できる

病因・病態・疫学

a 疫学

腺扁平上皮癌は, 非小細胞肺癌の 1~2% に認められるまれな組織型である。WHO 分類では, 腺癌成分および扁平上皮癌成分がそれぞれ少なくとも 10% 以上を占める腫瘍と定義されている。生検検体からの診断は困難であり, 確定診断は手術検体に依存することが多いため, 実際の頻度は過小評価されている可能性がある。

b 病因・病態

発生機序としては, 共通の多能性幹細胞から分化する過程で腺癌成分と扁平上皮癌成分が同時に発生するという仮説と, 腺癌が扁平上皮癌へ, あるいは扁平上皮癌が腺癌へ形質転換 (trans-differentiation) するという仮説が提唱されている。

分子学的には, 腺癌成分には高頻度に EGFR 遺伝子変異が認められ, 腺癌部に EGFR 遺伝子変異がある場合に, 扁平上皮癌成分においてもしばしば EGFR 遺伝子変異が検出されることが報告されている (約 15%)³⁵⁾。これらの遺伝子変異やエピジェネティック変化の解析は, 発症機序の解明のみならず, 治療戦略を検討する上でも重要な情報となる。臨床的には一般に腺癌単独と比較して予後不良とされている。

症候・身体所見

腺癌と同様に末梢型が多いとの報告がある³⁶⁾。しかし多くのケースで腫瘍径が大きい状況で発見されており, 咳嗽・喀痰・疼痛などの症状を認めることがある。

診断・検査

a 病理

肺腺扁平上皮癌は『肺癌取扱い規約』において, 「腺癌成分と扁平上皮癌成分の両性分かなり, それぞれが腫瘍全体の少なくとも 10% 以上を占める」とされているが, 成分は混在するもの, 連続的に移行するものなどさまざまである。そのため 10% の基準は便宜的なものである。一方の成分が 10% 未満の場合には, 所見の記載にとどめるとされている¹⁾。

b 腫瘍マーカー

非小細胞癌マーカーが上昇することが, 特に CEA が上昇することが多い。

c 確定診断

原則気管支鏡検査や喀痰細胞診検査で診断すべきではない。手術検体により腺扁平上皮癌と診断されるケースが多く, 術前診断率は 6~14% 程度と低い³⁷⁾。

治療と予後

治療方針は非小細胞肺癌に準じ, 臨床病期, 年齢, performance status (PS) などを考慮して手術, 放射線, 化学療法を選択施行する。腺癌や扁平上皮癌に比較し予後不良とされ, 肺癌登録合同委員会における 2010 年肺癌外科切除例の全国集計では, 大細胞癌や小細胞癌に次ぎ術後 5 年生存率 53.2% と報告されている³⁸⁾。術後病理にて血管やリンパ管への侵襲が肺腺癌症例および扁平上皮癌症例に比べ多かったと報告されており³⁹⁾, 予後不良の一因である可能性がある。

治療として確立されたレジメンはなく, 腺癌成分と扁平上皮癌成分の割合を考慮され治療選択されること